

УДК:616.329-08-059

Ж.А.Арзыкулов, Е.Б.Ижанов, Е.Ш.Абзалбек

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Отдаленные результаты мультимодальной терапии рака пищевода

Аннотация. Представлены непосредственные и отдаленные сравнительные результаты хирургического и мультимодального методов лечения местнораспространенного рака пищевода. Предоперационная полихимиотерапия не ухудшает непосредственные и улучшает отдаленные результаты лечения.

Ключевые слова: рак пищевода, полихимиотерапия, хирургическое лечение.

Рак пищевода занимает шестое место в структуре заболеваемости злокачественными опухолями в мире. Ежегодно в республике выявляется около 1400 больных раком пищевода, а погибает от данного недуга более 1000 человек в год [1].

Лечение рака пищевода остается одной из наиболее сложных проблем современной онкологии. Это обусловлено поздней диагностикой опухолевого процесса, когда доля больных имеющих уже местнораспространенный процесс на момент обращения к врачу составляет 70-80%.

Наиболее радикальным методом лечения рака пищевода является хирургический. Однако этот метод оказывается эффективным лишь при ранних стадиях заболевания. Одной из основных неудач в лечении является большая местная распространенность опухолевого процесса на момент обращения за специализированной помощью. Таким образом, при местно-распространенных опухолях пищевода низкий процент резектабельности не позволяет у большинства больных выполнить радикальное хирургическое вмешательство, то есть применение только лишь одного локального метода воздействия оказывается недостаточным [2,3].

Другим направлением в поиске наиболее оптимального вида лечения рака пищевода является применение предоперационной комбинации лекарственного и лучевого воздействия на опухоль с последующей операцией - мультимодальная терапия [4,5].

Предоперационная химиолучевая терапия рака пищевода приобретает большое значение, так как может быть применена у большинства больных как компонент комплексного метода лечения местнораспространенного процесса. Ее основной целью является увеличение количества радикальных резекций, подавление субклинических метастазов, уменьшение рисков развития отдаленных метастазов и, как следствие, увеличение продолжительности жизни и улучшение результатов лечения в целом.

Отсутствие единого мнения о целесообразности и эффективности проведения предоперационной терапии, методах профилактики послеоперационных осложнений у больных раком пищевода явилось предпосылкой для проведения нашего исследования.

Цель исследования

- улучшение результатов лечения местнораспространенного рака пищевода.

Материалы и методы

В отделении онкохирургии органов ЖКТ Казахского НИИ онкологии и радиологии проведено лечение 107 больных местнораспространенным раком пищевода, из которых 54 больным (основная группа) назначена мультимодальная терапия

неоадьювантная полихимиотерапия (3 курса) + лучевая терапия + операция и 53 пациентам - только хирургическое лечение. Средний возраст больных в группе мульти модального лечения составил $53,5 \pm 25,5$ лет, в группе хирургического лечения - $57,5 \pm 20,51$ лет. Полихимиотерапия проводилась по схеме: доцетаксел – 75 мг/м² 1 день + цисплатин 75 мг/м² 1 день 3 курса с интервалом между курсами 3 недели. Параллельно 3 курсу проводилась лучевая терапия РОД - 2 Гр, СОД - 50 Гр. Последним этапом для мультимодальной терапии выполнялось оперативное вмешательство в объеме субтотальной резекции пищевода с гастрозоофагопластикой со стандартной двухзональной лимфодиссекцией. Данная операция выполнена всем 105 больным.

Результаты и их обсуждение

Во время проведения мультимодальной терапии 2 пациента выбыли из программы лечения в связи с прогрессированием процесса, им произведено оперативное лечение. При проведении неоадьювантной химиолучевой терапии в основной группе эффективность терапии отмечена в 61,5%. Патоморфоз III-IV степени достигнут в 32,7%, I-II

в 57,7%. Токсичность химиолучевой терапии отмечалась I и II степени, за счет эмитических реакций и не лимитировала проведение мультимодальной терапии.

Во всех 105 случаях выполнена субтотальная резекция пищевода. При хирургическом методе лечения у 13 больных из 53 отмечено 15 ($28,4 \pm 0,46$) различного рода осложнений. Среди них наиболее часто встречающиеся осложнения - послеоперационная пневмония (4) ($20,8 \pm 0,24$). В 2-х случаях - летальный исход; в первом случае по причине инфаркта миокарда (1,9%), во втором случае - РДС (1,9%).

В основной группе у 15 из 52 пациентов, отмечено 16 осложнений (30,7%). Превалирующее число осложнений принадлежит послеоперационной пневмонии (9 больных - $17,4\% \pm 0,22$). В данной группе так же отмечена летальность в 2 случаях. В первом по причине РДС (3,8%), во втором - за счет несостоятельности ПЖА (1,9%).

Прослежена годичная выживаемость у 101 из 105

Таблица 1 - Двухгодичная выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умерло	2-летняя выживаемость	Безрецидивная 2-летняя выживаемость
Хирургический	51	23	28 (54,9 ± 3,65)	24 (47,5 ± 3,55)
Мультимодальный	50	20	30 (60 ± 3,65)	28 (53,8 ± 3,65)

Таблица 2 - Пятилетняя выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умерло	5-летняя выживаемость	Безрецидивная 5-летняя выживаемость
Хирургический	51	42	9 (18,9 ± 3,80)	8 (17 ± 3,65)
Мультимодальный	50	34	16 (32,7 ± 4,15)	14 (28,8 ± 3,90)

больных, переживших ранний послеоперационный период и пролеченных по сравниваемым схемам. Хирургическую группу составили 51 больной, в группе мультимодальной терапии отслежены ближайшие (2 года) и отдаленные (5 лет) результаты лечения для 50 пациентов.

В таблице 1 представлены данные о двухлетней выживаемости изучаемых групп больных.

Отмечается увеличение количества пациентов, переживших двухлетний срок наблюдения без метастазов и рецидивов при мультимодальном лечении - 53,8 ± 3,65 против - 47,5 ± 3,55 при хирургическом. Аналогично, отмечается увеличение общей выживаемости в группе мультимодального лечения - 60 ± 3,65 по сравнению с 54,9 ± 3,65 при хирургическом.

Пятилетние результаты лечения прослежены также у 101 больного (таблица 2).

В группе хирургического лечения по настоящее время живы 9 (18,9 ± 3,80) человек, в то время как в группе мультимодальной терапии пятилетний рубеж перешагнули 16 (32,7 ± 4,15) пациентов. Безрецидивная пятилетняя выживаемость также выше в группе мультимодальной терапии - 28,8 ± 3,90 против 17 ± 3,65 в группе хирургического лечения. Отмечается снижение темпов смертности после лечения как в группе хирургического, так и в группе мультимодального лечения в сравнении первых двух и последующих трех лет. Так, если в первые 2 года умерло 37,2% и 32% больных в группах хирургии и мультимодальной терапии, то в последующие годы эти цифры составили 31,3% и 30,0% соответственно. Эти показатели соответствуют литературным данным о наибольшем обнаружении прогрессирования опухолевого процесса и смертности пролеченных больных именно в первые два года после радикального вмешательства.

Таким образом, проведение мультимодальной терапии больным местнораспространенными формами рака пищевода не ухудшает непосредственные результаты и улучшает отдаленные результаты лечения.

Список литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д. и др. Показатели онкологической службы республики Казахстан за 2010 год - Алматы, 2011.
2. Altorki N.K., Skinner D. - Occult cervical nodal metastasis in esophageal cancer: preliminary results of three-field lymphnode dissection // J. Thoracic Cardiovasc Surg. - 2001. - Vol. 113, N3. - P. 538-544.
3. Huerbein M., Rau B., Schlag P. Laparoscopy and laparoscopic ultrasound for staging of upper gastrointestinal tumors // Eur. J. Surg. Oncol. - 1999. - Vol. 21. - P. 50-55.
4. Arzykulov Zh., Izhanov E., Utebayeva A. et al. - Evaluation of preoperative chemoradiotherapy in esophageal cancer patients // ESMO. - 13 world congress on gastrointestinal cancer. 2011, Barcelona, Spain.
5. Arzykulov Zh., Izhanov E., Abzalbek E. - Multimodality treatment of locally advanced resectable esophageal cancer // World congress on gastrointestinal cancer- Asian perspectives. - 2012, Shanghai, China.

Тұжырым

Ж.А.Арзыкулов, Е.Б.Ижанова, Е.Ш.Абзалбек

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Өңеш обырының мультимодальды терапиясының
бөлек қорытындысы

Өңеш қатерлі ісігінің жергілікті таралған түрінің оташылдық және мультимодальды күрделенген емінен соң, тікелей және кейінгі нәтижелерінің салыстырмалы түріндегі көрсеткіштері ұсынылды. Оташылдық ем алдындағы жүргізілген полихимиотерапия тікелей нәтижелері еш өзгеріссіз болса, кейінгі көрсеткіштеріше оң әсер етп.

Түйінді сөздер: Өңеш қатерлі ісігі, полихимиотерапия, отаеми.

Summary

Z.A.Arzykulov, E.B.Izhanov, E.Sh.Abzalbek

Long-term results of multimodal therapy of esophageal cancer

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

We present direct and long-term comparative results of surgical and multimodal methods of treatment of locally advanced esophageal cancer. Preoperative polychemotherapy does not impair immediate and improves long-term results of treatment.

Keywords: esophageal cancer, polychemotherapy, surgical treatment.